

CAPÍTULO 7.12

Amenorrea

PERFIL EUNACOM 1.03.3.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Amenorrea

Definición

- **Primaria:** nunca ha menstruado y tiene ≥ 16 años (o ≥ 14 sin caracteres sexuales secundarios)
- **Secundaria:** ausencia de menstruación > 3 meses en mujer que antes menstruaba

Primer paso siempre: descartar embarazo

$> \beta$ -hCG antes de cualquier otro estudio

Amenorrea Primaria

Causas y evaluación

- Examinar caracteres sexuales secundarios (mamas, vello) y genitales
- Si **no hay útero** $\rightarrow$ pensar en **Síndrome de Mayer-Rokitansky** (agenesia vaginal/uterina, cariotipo 46XX) o **Síndrome de Morris** (resistencia a andrógenos, cariotipo 46XY, fenotipo femenino)
- Si **hay útero pero no menarquia** $\rightarrow$ evaluar nivel del bloqueo (ver algoritmo secundaria)

Amenorrea Secundaria

Algoritmo por FSH y LH

TABLA 7.12.1: FSH/LH VS ESTRÓGENOS		
FSH/LH	ESTRÓGENOS	DIAGNÓSTICO
$\uparrow\uparrow$	$\downarrow$	Falla ovárica primaria (menopausia precoz, Sx Turner)
Normal o $\downarrow$	Normal o $\downarrow$	Causa hipotalámica o hipofisaria

Causas hipotalámicas frecuentes

- Estrés, anorexia, ejercicio excesivo $\rightarrow \downarrow$ GnRH
- **Síndrome de ovario poliquístico (SOP/PCOS):** la más frecuente de amenorrea secundaria; TSH normal; $\uparrow$ LH / FSH normal $\rightarrow \uparrow$ andrógenos $\rightarrow$ oligomenorrea/amenorrea + acné + hirsutismo

Causas hipofisarias

- **Prolactinoma** ($\uparrow$ prolactina $\rightarrow$ inhibición de GnRH) $\rightarrow$ galactorrea + amenorrea - **Síndrome de Sheehan** (infarto hipofisario post-parto)

Causas uterinas

- **Síndrome de Asherman:** sinequias uterinas post-legrado o endometritis $\rightarrow$ amenorrea secundaria estructural

Resumen de Diagnóstico diferencial

TABLA 7.12.2: CAUSA VS CLÍNICA DIFERENCIADORA		
CAUSA	CLÍNICA DIFERENCIADORA	EXAMEN CLAVE
SOP	Irregular + androgenismo	Ecografía (ovarios poliquísticos) + LH/FSH
Prolactinoma	Galactorrea + $\uparrow$ prolactina	Prolactina + RNM hipofisaria
Sheehan	Post-hemorragia puerperal	Perfil hormonal completo
Falla ovárica	$\uparrow$ FSH + signos de menopausia	FSH

| Asherman | Post-legrado | Histeroscopia |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 19 años consulta por amenorrea secundaria de 8 meses. Nunca antes había tenido irregularidades. IMC 22 kg/m². Test de embarazo en orina (β -hCG) resulta negativo. Examen físico y ginecológico normal."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Estudio de Amenorrea Secundaria: el paso inicial siempre es descartar Embarazo (β -hCG). Tras descartar embarazo, el algoritmo diagnóstico incluye: (1) Medir TSH y Prolactina; (2) Prueba de Progesterona (Medroxiprogesterona 10 mg/d por 10 días): si sangra, indica anovulación (ej. SOP); si no sangra, sugiere causa uterina o hipoestrogenismo; (3) Medir FSH/LH para diferenciar falla ovárica prematura (FSH alta) de causa hipotalámica-hipofisaria (FSH baja/normal).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Amenorrea secundaria: ausencia de menstruación ≥ 3 ciclos regulares o >90 días si irregulares.
- SIEMPRE descartar embarazo primero, independientemente de lo que diga la paciente.
- Estudio actual: estradiol, progesterona, FSH/LH, prolactina, TSH, hCG, hormona antimülleriana.
- Estradiol bajo + FSH/LH alta = hipogonadismo hipergonadotrópico (falla ovárica). <40 años = menopausia precoz.
- Estradiol bajo + FSH/LH baja = hipogonadismo hipogonadotrópico (hipotalámico-hipofisario).
- Todo normal + no embarazada = causa uterina (síndrome de Asherman).
- Estradiol normal + progesterona baja + LH alta = anovulación (SOP).
- Amenorrea primaria: sin menarquia a los 15 años con pubertad, o 13 años sin pubertad.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (AMENORREA)

PREGUNTA 1

Mujer de 35 años con amenorrea de 4 meses. Exámenes: estradiol bajo, FSH 65 mU/mL (elevada), LH 50 mU/mL (elevada), hormona antimülleriana baja, hCG negativa. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Síndrome de ovario poliquístico
- B)** Menopausia precoz (falla ovárica prematura)
- C)** Síndrome de Sheehan
- D)** Síndrome de Asherman
- E)** Hiperprolactinemia

RESUMEN: AMENORREA

La amenorrea secundaria es la ausencia de menstruación por ≥ 3 ciclos regulares o >90 días si irregulares. Causas fisiológicas: embarazo, lactancia, menopausia. Causas patológicas: hormonales y anatómicas. El estudio clásico (obsoleto pero útil para fisiopatología) usa prueba de progesterona (positiva = anovulación/SOP) y prueba de estrógeno+progesterona (positiva = hipogonadismo, negativa = causa uterina). El estudio actual pide todos los exámenes juntos: estradiol, progesterona, FSH/LH, prolactina, TSH, hCG, hormona antimülleriana (reflejo de reserva ovárica). Interpretación: estradiol bajo + FSH/LH alta = hipogonadismo hipergonadotrópico (falla ovárica, si <40 años = menopausia precoz). Estradiol bajo + FSH/LH baja = hipogonadismo hipogonadotrópico (causa hipotalámico-hipofisiaria). Todo normal + no embarazada = causa uterina (ej. síndrome de Asherman). Estradiol normal + progesterona baja + LH alta = anovulación (SOP). Amenorrea primaria: ausencia de menarquia a los 15 años con desarrollo puberal o 13 años sin desarrollo puberal.